

ITU / PNA · pediátrica

ITU febril no lactente é PNA até prova em contrário. Coleta adequada (cateter/punção) evita falso positivo; antibiótico precoce reduz cicatriz renal.

Coleta

Lembre - Coleta

Saco coletor serve para afastar (se negativo), não para confirmar. Diagnóstico confiável: cateterismo ou punção supra-púbica com urocultura.

Timeline: febre sem foco !' urocultura válida !' ATB !' USG e seguimento conforme idade/recorrência.



Conduta

- Lactente febril / tóxico: ATB EV empírico após coleta
- Criança maior com cistite típica: ATB VO pode bastar
- Ajustar conforme cultura e antibiograma
- Fatores de risco: fimose, constipação, disfunção miccional, refluxo

Imagem — visão clássica de prova

Exame | Quando pensar

USG vias urinárias | 1ª ITU febril / lactente

Uretrocistografia | USG alterado, ITU atípica/recorrente (protocolos variam)

Cintilografia DMSA | Avaliar cicatriz em selecionados

Armadilha de prova

Atencao - Armadilha de prova

Tratar 'ITU' só com leucócitos no saco coletor sem cultura adequada gera overtreatment. Confirme coleta válida antes de longos esquemas e investigação invasiva.

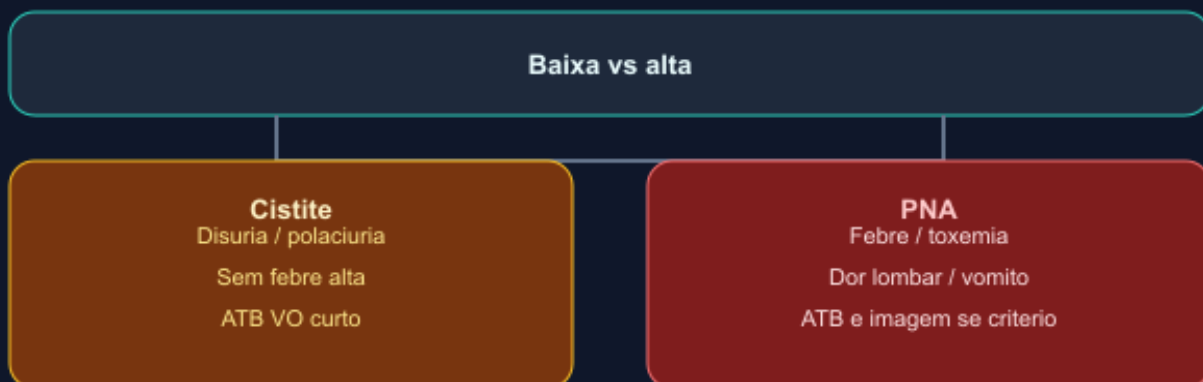
Para a prova — escalas e macetes

Lembre - Para a prova — escalas e macetes

Separar cistite de pielonefrite e saber quando pedir USG/DMSA é o que mais cai em ITU pediátrica de prova.

Febre, toxemia e dor lombar apontam para PNA; disúria sem febre sugere cistite em criança maior.

Cistite vs PNA



USG: anatomia/complicações. DMSA: cicatriz/pielonefrite confirmada em cenários selecionados.

Quando USG / DMSA

Ideia de prova

- 1 USG: 1ª ITU febril em lactente
- 2 USG: ITU atípica / massa / falha terapêutica
- 3 DMSA: cicatriz após PNA selecionada
- 4 Cistouretrografia: refluxo se indicado
- 5 Urocultura antes do ATB sempre que possível

ITU atípica ou recorrente = investigar

PNA × cistite

Achado | Cistite | PNA

Febre | Ausente/baixa | Alta, frequentemente

Estado geral | Bom | Toxemia / vômitos

Dor | Suprapúbica | Lombar/flanco

Internação | Rara | Comum se lactente/vômitos/dúvida

Diagnóstico e conduta

- Coleta adequada: jato médio (treinada), saco com cautela, cateter/punção no lactente
- ATB empírico guiado por idade/gravidade; ajustar pela cultura
- ITU atípica: massa, fluxo fraco, patógeno incomum, septicemia, falha — imagem precoce
- Profilaxia contínua não é rotina para toda ITU única

Armadilha

Atencao - Armadilha

Saco coletor positivo isolado não confirma ITU — confirme com método confiável antes de cronificar ATB e investigação invasiva.

Material de estudo para residência (R1). Não substitui protocolo institucional nem conduta clínica.

www.medhubr1.com.br - MedHub R1